

INTRODUCCIÓN

La ingestión de cuerpos extraños (CE) es una de las emergencias más frecuentes de consulta en una guardia pediátrica. Ocurre, generalmente, dentro del ambiente familiar y bajo el cuidado de los adultos. Se considera CE todo elemento deglutido o no por el paciente que puede entorpecer el normal tránsito por el tubo digestivo y predisponer a diversas complicaciones.

Por el inicio súbito y la inmediata instalación de síntomas, la ingesta de un CE crea una situación sumamente angustiante para el paciente y sus familiares, mayor aún si se trata de un niño. La mayoría de los CE (80 % a 90 %) que llegan al tubo digestivo lo pasan de modo espontáneo sin atascarse. Desde la era pre-endoscópica, existe el concepto que la mayoría de los CE son eliminados espontáneamente en forma segura. Esto es sostenido hasta el día de hoy, ya que solo 10 % - 20 % de los casos requiere algún tipo de intervención, y 1 % o menos requiere procedimientos quirúrgicos para su resolución.^{1,2}

Para la realización de este documento se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva en Pubmed y Biblioteca Cochrane. También fueron consideradas las guías de diagnóstico y tratamiento de diversos servicios de Argentina donde se atienden este tipo de emergencias pediátricas.

EPIDEMIOLOGÍA

El reporte del Centro de Control de Intoxicaciones de EE. UU. refiere más de 110.000 casos reportados en 2011, de los cuales más del 85 % ocurrió en niños. La mayor incidencia es en niños de entre 1 y 5 años (media de 2,8 años). Sin embargo, se sospecha que el número sería mayor, ya que algunos no se

reportan y son manejados en el domicilio. Si bien estos datos son de la década pasada, reportes como el del Endoscopy Department del Hôpital Saint Antoine, Sorbonne Université, Paris del 2020 refieren datos similares.³

Los niños son particularmente vulnerables a la retención de objetos, dado el pequeño diámetro de su esófago comparado con esófagos de niños mayores o adolescentes.

Algunos pacientes pueden presentar patologías previas que predisponen a la retención de objetos deglutidos. Ellas pueden ser alteraciones en el reflejo de deglución, estenosis, anillos, dismotilidad, acalasia, esofagitis (incluso esofagitis eosinofílica), cirugía de reflujo tipo Nissen estrecho o las atresias de esófago.

TIPOS DE CUERPOS EXTRAÑOS

Los objetos más comúnmente ingeridos por los niños incluyen monedas en primer lugar, imanes, pilas, juguetes, joyas/bijouterie, botones, huesos o bolos de alimento.

Se han dividido los objetos según sus características en cuatro grupos: romos, punzantes, cortantes y complejos. Pueden, en algunos casos, compartir más de una característica. Es muy importante considerar el tamaño y la forma para evaluar su mejor manejo.

CE romos: son aquellos que, al no tener extremos punzantes, presentan poca probabilidad de enclavarse en la mucosa del órgano y, por lo tanto, se asocian a menor incidencia de perforaciones. Los CE romos pueden ser el “bolo de carne”. Su atascamiento se asocia a patología esofágica orgánica subyacente en la mayoría de los casos (90 %), como puede ser la Esofagitis Eosinofílica o la

Acalasia. La falta de piezas dentarias con mala masticación (un hecho no tan frecuente en pediatría) y la rápida deglución ayudan a que se produzcan estos atascamientos. Redondos como la moneda el cual es el C.E más frecuente en todas las series evaluadas, los lugares más comunes de estancamiento son las estrecheces anatómicas del esófago, principalmente la región cricofaríngea y la lesión que generan la hacen por compresión directa sobre la mucosa. Las pilas botón merecen un párrafo aparte. El principal mecanismo de lesión es la electrólisis y la producción de iones hidróxido. La acumulación de hidróxido aumenta rápidamente el entorno del tejido circundante a un pH de 12 a 13, este entorno altamente alcalino crea una necrosis licuefactiva que puede dar como resultado una lesión cáustica, otros mecanismos de lesión incluyen la toxicidad por liberación de contenido y la necrosis por presión directa y la complicación más temida es la perforación esofágica.

CE punzantes: son aquellos que presentan algún extremo en punta y, como consecuencia, alta probabilidad de enclavamiento. Incluyen espinas y cartílagos de pescado, huesos (vaca, pollo, conejo), agujas, alfileres, escarbadientes, alfileres de gancho, etc. La distracción a la hora de comer, la ingesta demasiado rápida y las comidas con muchos componentes que pueden ocultar o disimular la presencia de huesos o espinas son condiciones que predisponen a la ingesta de estos CE. Lo mismo ocurre con el uso de ortodoncias con paladar acrílico, que impiden la sensación punzante sobre el paladar.

CE cortantes: son aquellos que presentan bordes o extremos filosos, con capacidad de producir cortes en la superficie con la cual se ponen en contacto.

En este grupo, se encuentran los vidrios, las hojas de afeitar, las tapas de aluminio, las porciones de latas, etc.

CE complejos: son aquellos que, por su tamaño o estructura, se acompañan de mayor dificultad en su extracción o causan complicaciones y necesidad potencial de cirugía. Se incluyen las prótesis dentarias, utensilios de cocina (tenedores, cucharas, cuchillos), autos de colección, etc. En lo referido a los “paquetes” de drogas, se aconseja no realizar endoscopia por el riesgo de su rotura y la consiguiente probabilidad de muerte por sobredosis.⁴

DIAGNOSTICO

Anamnesis: Es fundamental realizar un buen interrogatorio a los padres o mayores que acompañaban al niño en el momento del accidente para conocer las características del objeto u objetos ingeridos. Se deben considerar antecedentes de enfermedades esofágicas (orgánicas o funcionales), como atresia de esófago, Nissen u otra cirugía previa, estenosis o patologías sistémicas que puedan tener repercusión en el esófago (colagenopatías, miopatías, accidente cerebrovascular –ACV–, etc.), como también enfermedades psiquiátricas o conductuales. Se deben evaluar las características del objeto ingerido: forma, tamaño, número y tiempo transcurrido desde la ingesta.

Evaluación inicial: En algunos pacientes, no se presentan síntomas. Cuando hay síntomas presentes, estos son, generalmente, inespecíficos. Se deberán evaluar signos y síntomas presentes para orientarse en su ubicación. Los pacientes pueden presentar disfagia, vómitos, sialorrea, ahogamiento, tos, disnea y rechazo

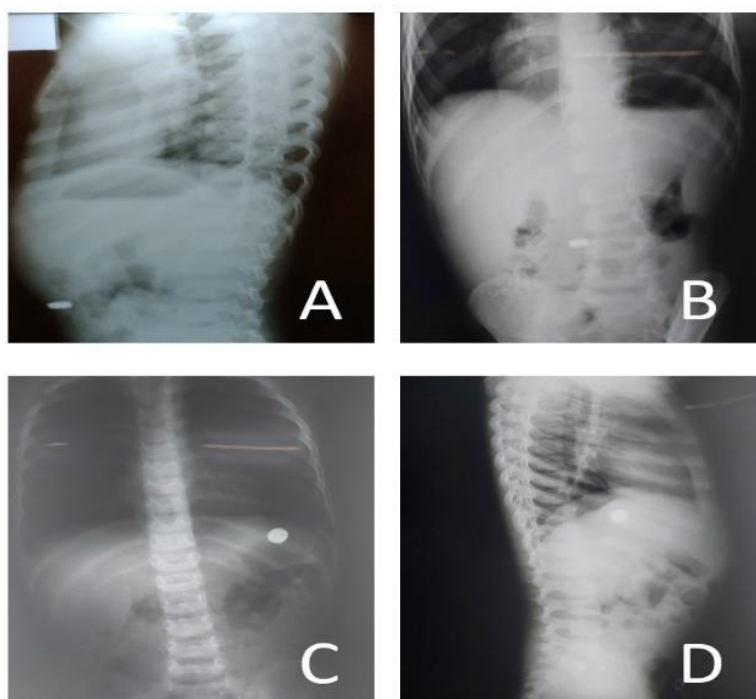
al alimento. Otras veces, puede haber irritabilidad o inquietud, esputo sanguinolento, sensación de CE o dolor en la garganta, el cuello, el tórax o el abdomen, dependiendo de su localización y de las horas transcurridas desde la ingesta. Si el CE se encuentra desde hace tiempo, pueden aparecer anorexia, vómitos, fiebre y halitosis.⁵

Radiografía de cuello, tórax y abdomen (frente y perfil): (Figura 1,2,3) Debería ser realizada toda vez que haya sospecha de ingesta de un CE. A veces, limitar la evaluación al tórax puede resultar en un error diagnóstico, como ocurre en la ingesta de múltiples objetos, aquellos en la faringe o los que pasaron el píloro. En algunos centros estas proyecciones se realizan con el paciente en decúbito dorsal lo cual permitiría una ubicación más precisa del cuerpo extraño ubicado en cavidad abdominal. Un 20 % de los objetos ingeridos se localizan en el esófago. Hay áreas que fisiológicamente predisponen a su estancamiento, que son el espacio cricofaríngeo (C6), torácico superior (T1), arco aórtico (T4), bifurcación traqueal (T6), hiato esofágico (T10-T11). Otros sitios de retención en el aparato digestivo son píloro, duodeno, válvula ileocecal y recto. Cerca de dos tercios de los CE son radiopacos. Pero, a veces, son radiolúcidos, como bolos de alimento, plástico, aluminio. O son difíciles de visualizar, como agujas o espinas. Siempre que el paciente presente síntomas o ante la sospecha de CE, conviene realizar una videoendoscopia. Nunca se deben realizar estudios contrastados si hay síntomas de CE atascado por el riesgo de aspiración; incluso el contraste puede dificultar el estudio.⁶

Figura 1. Radiografía de cuello perfil y frente mostrando cuerpo extraño en esófago

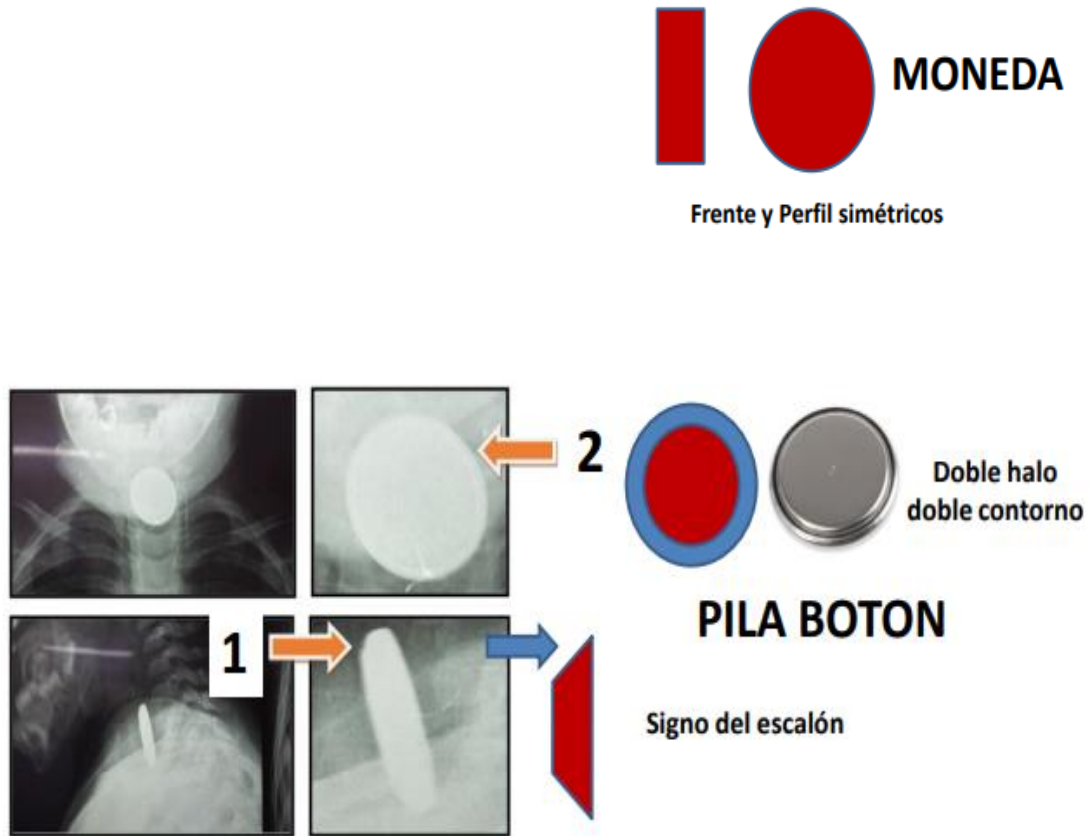


Figura 2. Radiografías de abdomen perfil y frente mostrando cuerpo extraño ingerido



TAC y/o resonancia nuclear magnética: solo se deben realizar ante eventuales complicaciones (perforación, flemón, absceso). Es común identificar todo objeto redondo y radiopaco como moneda, dado que es el CE más frecuente. Sin embargo, es muy importante la correcta diferenciación con las pilas botón, ya que un error diagnóstico puede traer serias consecuencias. Para evitar el retraso diagnóstico es muy importante reconocer las diferencias radiológicas entre monedas y pilas botón, estas últimas son bilaminares observándose en la radiografía de frente la presencia de un doble halo o contorno mientras que en el perfil se puede observar un sector con una ligera protuberancia, siendo este el signo del escalón y correspondiendo al polo negativo de la pila (ánodo). Últimamente, en algunas instituciones, se incluyen detectores de metales en la evaluación. Si bien son adecuados, también son costosos, no emiten radiación y requieren poco entrenamiento.⁷

Figura 3. Diferencias radiológicas entre moneda y pila/botón ingeridos



Las imágenes superiores (A - B) corresponden a incidencias radiográficas realizadas con el paciente de pie donde se podría inferir su progresión intestinal, asimismo las inferiores (C-D) fueron realizadas posteriormente con el mismo paciente en decúbito dorsal. (co-ingesta de imanes ubicados en cámara gástrica antes de su extracción endoscópica)

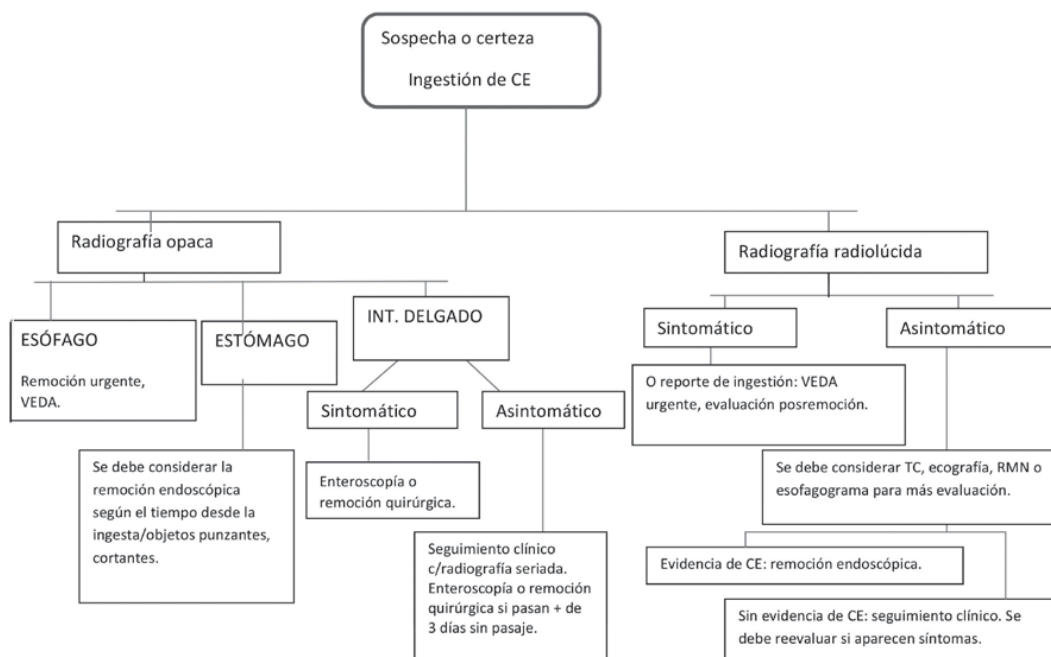
MANEJO

Una vez que la ingesta de CE es diagnosticada, el endoscopista debe decidir si la intervención es necesaria o no, y el grado de urgencia. La decisión estará influida por la edad del paciente, la condición clínica, la característica y el tamaño del CE, el lugar de atascamiento, el tiempo desde la ingesta y la experiencia del operador. Siempre se debe evaluar el estado cardiorrespiratorio. Si hay compromiso respiratorio, se debe administrar oxígeno y considerar asegurar la vía aérea.

Todo CE localizado en el esófago, cualesquiera sean sus características, se considera una emergencia, por lo cual debe ser extraído antes de las 24 h de ingestión por el alto riesgo de la lesión por decúbito y posterior perforación.

En el estómago y en el duodeno, la conducta va a depender del tipo de CE, su tamaño y tiempo desde la ingesta (Figura 4).

Figura 4. Algoritmo de manejo del cuerpo extraño ingerido



Las pilas por sus localizadas en esófago deben ser extraídas de manera inmediata y no es necesaria la preparación del paciente ni el ayuno debido a que se consideran una emergencia endoscópica.

Se considera que, si la pila pasó el píloro, se debe hacer seguimiento radiológico, ya que son pocos los casos de lesión intestinal u obstrucción por ellas. Después de la extracción de la pila, el niño debe ser observado por posibles complicaciones, como fístula traqueoesofágica, otras perforaciones de esófago, parálisis de cuerdas vocales por lesión del nervio recurrente, mediastinitis, neumotórax, neumoperitoneo, traqueomalacia, neumonía por aspiración.

La causa más común de muerte es la fístula aorto-esofágica, que puede ocurrir hasta varios días después de la remoción. Siempre los procedimientos endoscópicos terapéuticos implican riesgos potenciales de perforación, motivo por el cual deberán ser realizados por endoscopistas adecuadamente entrenados, con instrumental específico, con apoyo anestésico, quirúrgico y de personal asistente capacitado. En caso de no contar con ellos, y según la característica del CE, la condición clínica del paciente y siempre que el tiempo transcurrido desde la ingesta lo permita, se tratará de derivar a un centro de mayor complejidad.

De acuerdo a todas las consideraciones antes mencionadas, se decidirá la conducta a seguir:

Laringoscopia: será el procedimiento de elección en los casos de espinas y cartílagos de pescado, ya que la mayoría se localizan en zonas que están al alcance de la resolución por esta vía, como en las valéculas, el paladar, la base de la lengua, la epiglotis, los espacios amigdalinos y los senos piriformes. La

ausencia de visualización del CE en la orofaringe obliga a la evaluación endoscópica más completa.

Resolución endoscópica: Esta debe ser realizada por un endoscopista con experiencia en la extracción de CE o alguien en formación con su referente, contar con instrumental adecuado para ello (canasta Rotnet, cesta Dormia, pinza diente de ratón o de cocodrilo, pinza trípode) y un asistente con la preparación adecuada.

Se podrá adoptar una conducta expectante en niños y adultos con ingesta de CE romos pequeños y cuando el CE haya pasado el píloro. Se controlará su progresión con radiografías seriadas y su eliminación por vía natural.

Cuando el objeto es mayor de 20 mm de diámetro o de 5 cm de longitud, es dificultoso que pueda pasar el píloro en un niño pequeño en forma espontánea, por lo cual, cualquiera sea su característica, se sugiere su extracción endoscópica. Cuando el CE es de características cortantes, se recomienda el uso de un sobretubo o de protectores de látex. Una vez que el CE es tomado, debe ser introducido en el sobretubo y, de esta forma, se evita la lesión de la mucosa al intentar retirarlo.

Se evaluará la extracción quirúrgica si el objeto es cortopunzante/pila que no progrese y presente síntomas.

Las últimas guías europeas (ESPGHAN) recomiendan estrategias de neutralización del pH en las pilas botón impactadas en el esófago, como una forma de limitar el daño producido por ellas. En niños mayores de un año administrar 10 ml de sucralfato cada 10 minutos (3 dosis) o 10 ml de miel cada 10 minutos (6 dosis) antes de la endoscopia, y una vez removida

endoscópicamente la pila botón y en ausencia de signos de perforación administrar 50 a 150 ml de ácido acético 0.25 %.

En todos los casos es importante contar con un consentimiento informado previo al procedimiento que se va a realizar que explique las eventuales complicaciones inherentes a la presencia del CE o como consecuencia de las maniobras por realizar.

Los riesgos de complicaciones y factores que sugieren una buena resolución endoscópica dependen de lo siguiente:

- Tipo y tamaño del cuerpo extraño.
- Tiempo desde la ingesta y lugar de atascamiento
- Patología digestiva previa que favorece el atascamiento
- Enfermedades asociadas como factor de comorbilidad
- En presencia de eventuales complicaciones por el CE

Tabla 1. Indicaciones de extracción de cuerpo extraño ingerido

Esofágicos	Todos deben ser extraídos
Gastroduodenales	Afilados y puntiagudos
	>5 cm de longitud
	>2 cm de ancho
	Contienen sustancias cáusticas
Estacionarios	Luego de 4 semanas en el estómago
	Luego de 1 semana en duodeno

SEGUIMIENTO Y CONTROLES

Evaluación post-resolución: Es importante la visualización endoscópica de las probables complicaciones (erosión, sangrado, úlcera, hematoma, perforación). Se debe realizar radiografías de control ante la aparición de síntomas que puedan hacer sospechar una complicación post-procedimiento, en especial en aquellos pacientes en los que la resolución fue dificultosa.

Internación: Se mantendrá la hospitalización hasta asegurarse la tolerancia oral. En aquellos que, por las lesiones observadas endoscópicamente luego de la extracción del CE o cuando esta ha sido muy cruenta, es conveniente la observación durante 48 h y la utilización de antibióticos endovenosos. También se debe realizar radiografía de control.

Conducta posterior: se comenzará una dieta líquida o licuada. Todo paciente será informado de retornar al hospital para su evaluación si los síntomas persisten luego de las 48 h o si, en cualquier momento, presentase fiebre, escalofríos o dolor intenso.⁸

Perforación: el retraso en el diagnóstico y/o en la resolución de la perforación es la principal causa del incremento de la morbilidad. Los pacientes que se presentan con situaciones avanzadas pueden presentar sepsis y, a veces, tener compromiso pleural y mediastinal. Con perforaciones tardías, la pared esofágica se encuentra inflamada o necrótica y no resiste la sutura que se pueda realizar, lo que provoca una fístula.

El diagnóstico se realiza sobre la base del antecedente, la existencia de dolor cervical, odinofagia, disfagia, crepitación, celulitis o, en casos más avanzados, un paciente séptico, con cuello tumefacto y fluctuante. Como métodos de

diagnóstico, la radiografía simple de cuello lateral muestra la presencia de aire prevertebral. La TAC se indicará en casos de sospecha clínica de perforación cuando no se pudo comprobar por otros métodos.⁹

Cirugía: está indicada ante la imposibilidad de extracción endoscópica y la presencia de complicaciones, como una perforación evidenciada previa o posterior al procedimiento. Debe considerarse la indicación quirúrgica también en casos de ubicaciones duodenales o fuera del alcance endoscópico, si el CE permanece en un mismo lugar por más de 4 días o aparecen síntomas de oclusión o perforación a dicho nivel. También se debe considerar ante CE que pasan al intestino delgado y no avanzan luego de 7 días o menos si los CE son filosos o puntiagudos.¹⁰

PREVENCIÓN

Considerando las graves complicaciones que puede traer la ingestión de CE, es fundamental tener en cuenta medidas preventivas dentro del ámbito doméstico y en el entorno del niño. Por su naturaleza, los niños son curiosos y exploradores. No alcanza con ocultar los objetos peligrosos; es importante no perder de vista al niño ni dejar al alcance objetos pequeños. Hay que asegurarse de que los juguetes o muñecos con que juegue diariamente no presenten adornos o detalles que se puedan desprender. Tampoco es conveniente dejar al niño menor de 3 años comiendo solo, aunque sepa hacerlo. En este caso, siempre debe haber un adulto supervisándolo para evitar que se atragante con alimentos sólidos.

REFERENCIAS

1. Molina Mata M, Cabarcas Maciá L, Rodríguez Martínez A. Ingesta de cuerpo extraño. En: Junta de Andalucía. Manual clínico de urgencias en pediatría. Visitado el 07/04/2026. Disponible en: <https://manualclinico.hospitaluvrociio.es/urgencias-de-pediatria/accidentes-e-intoxicaciones/ingesta-de-cuerpo-extrano/>.
2. Alarcón G, Antoniska M. Ingesta de Cuerpo extraño en pediatría. En: Sociedad Argentina de Pediatría. PRONAP. 2025;(1):36-52.
3. Becq A, Camus M, Dray X. Foreign body ingestion: dos and don'ts. *Frontline Gastroenterol*. 2020;12(7):664-70.
4. Sethia R, Gibbs H, Jacobs IN, Reilly JS, Rhoades K, Jatana KR. Current management of button battery injuries. *Laryngoscope Investig Otolaryngol*. 2021;6(3):549-63.
5. Mubarak A, Benninga MA, Broekaert I, Dolinsek J, Homan M, Mas E, et al. Diagnosis, Management, and Prevention of Button Battery Ingestion in Childhood: A European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition Position Paper. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2021;73(1):129-36.
6. Braghetto MI, Rodríguez NA, Csendes JA, Korn BO. Perforación esofágica: experiencia clínica y actualización del tema. *Rev Med Chile*. 2005;133(10):1233-41.
7. Lerner DG, Brumbaugh D, Lightdale, Jatana KR Risks of Swallowed Button Batteries *Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2020;70(4):542-6.
8. Comité Nacional de Gastroenterología Infantil. Consenso Nacional de Urgencias Endoscópicas en Pediatría 2016. *Arch Argent Pediatr*. 2017;115